

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	TATALAKSANA SIFILIS		
	No. Dokumen 351.16/I-SPO/DIR/VI/2026	No. Revisi 00	Halaman 1 / 14
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 19 Juni 2026	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada  dr. Resti Lestantini, M. Kes	
Pengertian	1. Sifilis adalah Infeksi Menular Seksual (IMS) kronis yang disebabkan oleh bakteri <i>Treponema pallidum</i>, bersifat sistemik sejak awal, dapat menyerang berbagai organ dengan gejala khas maupun fase laten tanpa gejala, mampu menyerupai banyak penyakit, menular ke janin, namun dapat disembuhkan. 2. Stadium I (Sifilis primer) : merupakan tahapan dengan gejala ulkus fgkumumnya tunggal (soliter), tepi teratur, dasar bersih, terdapat indurasi, tidak nyeri; juga dapat disertai pembesaran kelenjar getah bening regional. 3. Stadium II (Sifilis sekunder) : merupakan tahapan berupa terdapat lesi kulit yang polimorfik, tidak gatal dan lesi di mukosa, dapat menyerupai berbagai macam penyakit kulit lain, sehingga sering disebut sebagai the great imitator, sering disertai pembesaran kelenjar getah bening generalisata yang tidak nyeri (limfadenopati). 4. Stadium laten : merupakan tahapan dimana tidak ditemukan gejala klinis pada pasien, namun tes serologi sifilis (TSS) reaktif, baik serologi treponema maupun non-treponema. Dikategorikan Laten dini jika < 2 tahun dan laten lanjut jika > 2 tahun 5. Sifilis tersier : tahapan stadium lanjut yang muncul bertahun-tahun setelah infeksi awal tanpa pengobatan, ditandai dengan berbagai sindrom klinis, namun paling umum dibagi dalam tiga kelompok utama, yaitu gumma , sifilis kardiovaskular, dan neurosifilis lanjut . 6. TP Rapid (<i>Treponema pallidum</i> Rapid) : tes cepat sifilis kategori treponema spesifik yang mendeteksi antibodi terhadap treponema dengan hasil dalam 10–15 menit, sensitivitas 85–98% dan spesifisitas 93–98%, berfungsi sebagai pengganti TPHA dalam rangkaian pemeriksaan dengan RPR, namun tidak dapat membedakan infeksi aktif dari infeksi yang sudah diobati.RPR (<i>Rapid Plasma Reagin</i>) adalah salah satu pemeriksaan serologis sifilis non-treponema. 7. RPR (<i>Rapid Plasma Reagin</i>) : adalah tes serologis non-spesifik untuk sifilis yang mendeteksi antibodi terhadap lipid sel <i>Treponema pallidum</i> yang hancur, digunakan untuk skrining, mendeteksi infeksi atau reinfeksi aktif, serta memantau keberhasilan terapi, meskipun dapat memberikan hasil positif atau negatif palsu pada kondisi infeksi akut atau penyakit kronis lain.		

Tujuan	Sebagai acuan teknis terkait penapisan, diagnostik, pengobatan hingga pemantauan sifilis bagi dokter atau perawat/bidan yang bertugas di layanan IMS
Kebijakan	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome</i>, dan Infeksi Menular Seksual; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/90/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana HIV. 3. Pedoman Nasional Penanganan Infeksi Menular Seksual. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015 4. Pedoman Tatalaksana Sifilis untuk Pengendalian Sifilis di Layanan Kesehatan Dasar. Kementerian Kesehatan. 2013 5. Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi Indonesia, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin Indonesia (Perdoski), 2021 6. <i>Guidelines for Treatment of Treponema Pallidum (Syphilis)</i>. WHO. 2016 7. <i>Guidelines for the Management of Symptomatic Sexually Transmitted Infections</i>. WHO. 2021 8. <i>Update recommendations for the Treatment of Neisseria Gonorrhoeae, Chlamydia Trachomatis and Treponema Pallidum (Syphilis), and Recommendation on Syphilis Testing and Partner Services</i>. WHO. 2024
Prosedur	1. Klien yang datang ke ruang pendaftaran dengan membawa KTP dapat mengakses layanan pemeriksaan sifilis, baik secara mandiri melalui rawat jalan maupun melalui rujukan dari unit lain, sesuai alur pelayanan yang berlaku 2. Petugas pendaftaran mencatat identitas klien meliputi nama, NIK, tanggal lahir, alamat KTP, nomor telepon, dan data tambahan sesuai kebutuhan sistem informasi fasyankes. 3. Petugas pendaftaran mengarahkan klien ke ruang konseling atau pemeriksaan. 4. Dokter/perawat/bidan menyapa dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Layanan IMS. 5. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, penggalan riwayat penyakit, penilaian risiko seksual, dan interpretasi hasil tes laboratorium untuk menegakkan diagnosa sifilis dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan tidak menghakimi. 6. Petugas melakukan anamnesa pada pasien dengan menanyakan hal- hal berikut : a. Keluhan utama, serta maksud kedatangan: kesadaran sendiri, atas rujukan, hasil skrining b. Keluhan tambahan c. Riwayat penyakit sekarang: berapa lama keluhan yang saat ini diderita, riwayat pengobatan sebelumnya untuk kondisi keluhannya 7. Petugas juga menentukan ada tidaknya faktor risiko dengan menanyakan perilaku seksual pasien menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami, sesuai dengan usia dan budaya tanpa membuat asumsi pribadi. Beberapa pertanyaan yang diajukan meliputi :

		Neurosifilis: berkisar dari asimptomatik hingga simptomatik (nyeri kepala, vertigo, perubahan kepribadian, ataksia, demensia, pupil Argyll-Robertson)	<2 tahun sampai 20 tahun
		Gumma: kerusakan jaringan pada semua organ, manifestasi tergantung pada lokasi yang terkena	1-46 tahun (sebagian besar kasus 15 tahun)
	Kongenital	Dini: 2/3 asimptomatik, infeksi fulminan diseminata, lesi mukokutan, osteokondritis, anemia, hepatosplenomegali, neurosifilis	Awitan <2 tahun
		Lanjut: keratitis interstitialis, limfadenopati, hepatosplenomegali, kelainan tulang, gigi Hutchinson, neurosifilis	Menetap >2 tahun setelah lahir

Catatan: keluhan dan gejala dapat berubah apabila terjadi bersamaan dengan infeksi HIV

9. Petugas layanan IMS melakukan pemeriksaan penunjang laboratorium, meliputi TP Rapid dan RPR, sesuai dengan prosedur pengambilan sampel yang berlaku.

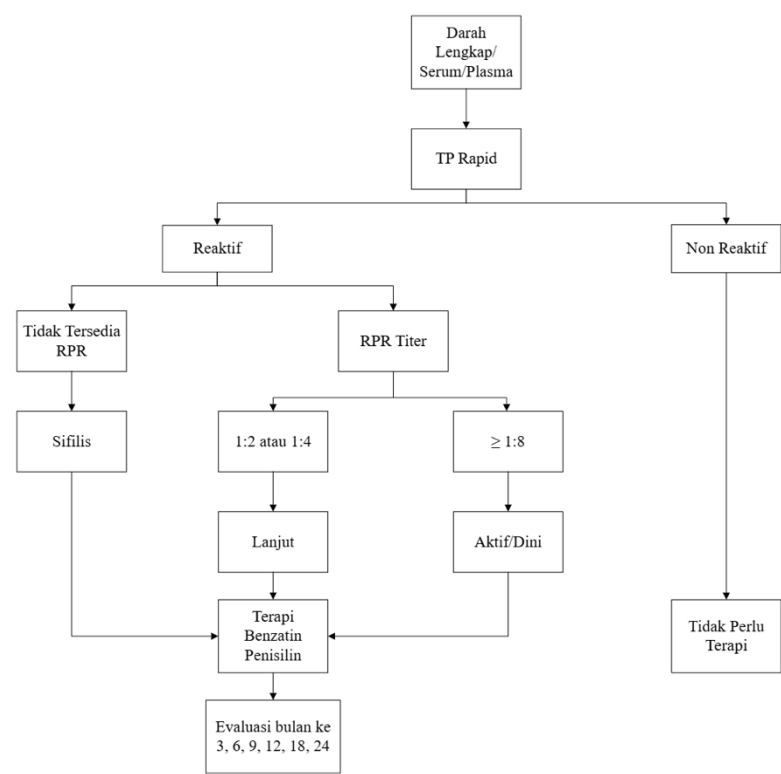
10. Petugas layanan IMS meminta pasien untuk menunggu hasil pemeriksaan.

11. Jika hasil pemeriksaan laboratorium sudah tersedia, petugas melakukan interpretasi hasil laboratorium sebagaimana tabel dan alur di bawah ini :

Tabel Interpretasi Hasil Pemeriksaan RPR dan TP Rapid

RPR	TP Rapid	Interpretasi
Reaktif	Non reaktif	Tes skrining nontreponema positif palsu
Reaktif	Reaktif	- Sifilis yang belum diobati - Sifilis lanjut yang pernah diobati - Frambusia
Non reaktif	Reaktif	- Sifilis sangat dini yang belum diobati - Sifilis dini yang pernah diobati - Frambusia
Non reaktif	Non reaktif	- Bukan sifilis - Sifilis masa inkubasi - Sifilis sangat lanjut - Sifilis bersamaan dengan infeksi HIV dan imunosupresi

Alur Tatalaksana Sifilis



*** setelah hasil TP rapid (R), tanyakan Riwayat terapi BP dalam 3 bulan, jika sudah terapi lakukan evaluasi tanda dan titer. Jika belum terapi, dilanjutkan dengan menentukan stadium klinis (primer/ sekunder) jika ada tanda klinis, jika tidak ada tanda klinis: tanyakan coitus suspectus; jika tidak diketahui tentukan dengan titer (RPR/ VDRL); jika tidak ada juga, maka dianggap sifilis lanjut.

12. Dokter menegaskan diagnosa sifilis serta memberikan tatalaksana yang sesuai berdasarkan hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, dan atau pemeriksaan penunjang, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Sifilis Dini (Sifilis primer, sekunder, laten dini)		
Kategori	Obat Pilihan	Obat Alternatif
Dewasa dan remaja	Benzathin penicillin G 2.4 juta unit, injeksi IM, dosis tunggal	- Doksisiklin* 2x100 mg, oral, selama 14 hari - Ceftriaxon 1 g, injeksi IM, selama 10-14 hari - Azithromisi n, 2 g oral, dosis tunggal
Ibu hamil	Benzathin penicillin G 2.4 juta unit, injeksi IM, dosis tunggal	Eritromisin 4x500 mg, oral,

				selama 14 hari • Ceftriaxon 1 g, injeksi IM, selama 10-14 hari • Azithromisi n, 2 g oral, dosis tunggal
Sifilis Laten Lanjut				
	Dewasa dan remaja	Benzathin penicillin G 2.4 juta unit, injeksi IM, sekali seminggu, selama 3 minggu **Jarak antara dua injeksi tidak boleh melebihi 14 hari		Doksisiklin* 2x100 mg, oral, selama 30 hari
	Ibu hamil	Benzathin penicillin G 2.4 juta unit, injeksi IM, sekali seminggu, selama 3 minggu **Jarak antara dua injeksi tidak boleh melebihi 14 hari		Eritromisin 4x500 mg, oral, selama 30 hari
Note: <i>*) Benzathine penicillin merupakan Drug of Choice sifilis dan dapat melewati sawar placenta, karena itu untuk pencegahan penularan sifilis dari ibu ke janin/anak memakai Benzathine penicillin. Jika di suatu faskes tidak tersedia mohon dicarikan di faskes lain atau dirujuk jika memungkinkan. Jika kontra indikasi BP/ skin tes positif barulah memakai terapi alternatif.</i>				
13. Pada pasien yang terindikasi mendapatkan pengobatan Benzatin Penicillin 2,4 juta unit, petugas (baik dokter, perawat, atau bidan) wajib melaksanakan prosedur pelayanan sesuai standar, yang meliputi: ○ Sebelum melakukan tindakan penyuntikan Benzatin Penicillin (BP), petugas layanan menenangkan pasien serta memberikan penjelasan secara jelas dan proporsional mengenai prosedur penyuntikan, manfaat terapi, potensi ketidaknyamanan selama dan setelah penyuntikan, pemantauan lanjutan titer sifilis pasca tindakan, kemungkinan efek samping serta risiko yang dapat timbul ○ Petugas layanan IMS selanjutnya meminta persetujuan pasien sebagai bentuk <i>informed consent</i> sebelum tindakan dilakukan				

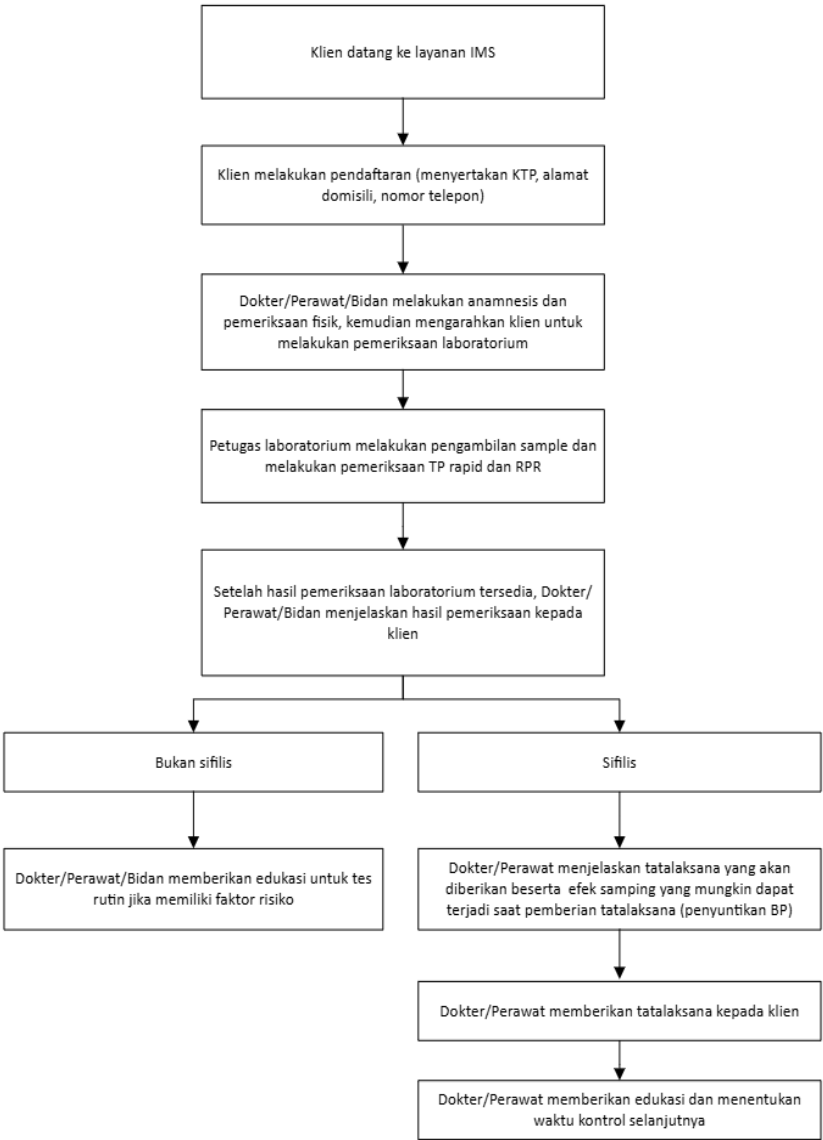
	○ Petugas menyiapkan alat dan bahan untuk penyuntikan Benzatine penicillin, meliputi : ○ Petugas melakukan uji kulit (skin test) terlebih dahulu untuk mendeteksi kemungkinan reaksi alergi atau anafilaksis akibat pemberian Benzatin Penicillin ○ Petugas melakukan uji kulit (skin test) dengan langkah-langkah sebagai berikut: ▪ Larutkan serbuk Benzatin Penicillin 2,4 juta unit dalam 10 cc aquadest steril (aquabidest) hingga tercampur sempurna. ▪ Ambil 1 cc dari larutan tersebut menggunakan spuit tuberkulin/1 cc (yang biasa digunakan untuk tes Mantoux). ▪ Buang sebagian isi spuit hingga tersisa $\pm 0,2$ cc larutan di dalam spuit. ▪ Suntikkan larutan tersebut secara intradermal (di bawah lapisan kulit), pada area volar lengan bawah. ▪ Beri tanda atau lingkari area penyuntikan untuk memudahkan observasi. ▪ Tunggu selama 15 menit, lalu amati adanya reaksi lokal berupa peningkatan diameter pembengkakan pada kulit (indurasi). ○ Jika terjadi peningkatan pembengkakan kulit dengan diameter >3 mm, hasil tes dinyatakan positif, yang berarti pasien memiliki alergi terhadap penisilin, serta penyuntikan lebih lanjut tidak dilakukan. ○ Tes kulit ini sebaiknya dilakukan setiap akan memberikan terapi injeksi Benzatin Penisilin. ○ Jika hasil skin test aman atau pasien tidak dicurigai memiliki alergi terhadap Benzatine Penicilline (BP), penyuntikan BP dosis penuh dapat dilanjutkan. ○ Petugas melakukan prosedur penyuntikan injeksi Benzatin Penicilline dengan tahapan sebagai berikut: ▪ Persiapkan pasien dalam posisi yang nyaman untuk injeksi intramuskular gluteal (berbaring miring atau tengkurap). ▪ Persiapkan vial Benzatine Penicilline yang sudah dilarutkan dalam 10cc aquabidest tadi dan sudah dipergunakan sebagian untuk skin test. ▪ Pergunakan spuit 10cc dan ganti needle dengan ukuran lebih besar, yakni 18G untuk menghindari kemungkinan penyumbatan karena pengkristalan larutan Benzatine Penicilline sebelum dilakukan penyuntikan ▪ Lakukan antisepsis pada kulit bokong menggunakan kapas alkohol, lalu tunggu hingga kering.
--	---

	▪ Suntikkan larutan Benzatine Penicilline 10 cc secara intramuskular dengan melakukan aspirasi terlebih dahulu sebelum injeksi. ▪ Keluarkan jarum dengan teknik yang aman dan tanpa tekanan berlebih. ▪ Buang alat suntik ke dalam wadah tahan tusukan (safety box). ▪ Catat tanggal kontrol selanjutnya pada kartu pasien atau rekam medis. ○ Setelah pasien menerima penyuntikan Benzatin Penicillin 2,4 juta unit, petugas layanan perlu melakukan monitoring pasca tindakan selama 30 menit untuk mengevaluasi kemungkinan timbulnya reaksi pasca penyuntikan, termasuk gejala awal reaksi anafilaksis, dan apabila ditemukan tanda-tanda reaksi tersebut, penatalaksanaan harus segera dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Syok Anafilaksis yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan. 14. Selain itu, petugas juga memberikan KIE terkait tatalaksana non farmakologis pada pasien dengan sifilis, meliputi : a) Edukasi mengenai sumber infeksi, cara penularan, komplikasi, pencegahan b) Anjuran abstinensia sampai dinyatakan sembuh c) Anjuran untuk membawa pasangan seksual dan bayi untuk dilakukan skrining dan pengobatan d) Kepatuhan berobat dan pemeriksaan lanjutan e) Anjuran untuk tes HIV bagi pasien dan pasangan seksualnya. 15. Petugas juga mengingatkan pasien bahwa setelah pengobatan sifilis dapat timbul reaksi Jarisch-Herxheimer dalam 24 jam pertama, berupa demam akut, nyeri kepala, dan mialgia. Tekankan bahwa reaksi ini merupakan respons terhadap terapi (bukan alergi penisilin), serta lebih sering terjadi pada sifilis dini (10–25%). 16. Pasien dianjurkan datang kembali untuk follow up pengobatan dengan tes serologi non treponema kuantitatif (RPR) serta dibandingkan dengan titer awal untuk memantau respons terapi dan kekambuhan, dengan jadwal sifilis dini pada 1, 3, 6, dan 12 bulan, serta sifilis lanjut pada 3, 6, 12, 18, dan 24 bulan pascaterapi. 17. Petugas menyatakan terapi berhasil bila titer serologi nontreponema turun ≥ 4 kali lipat dari awal, sedangkan peningkatan titer ≥ 4 kali lipat yang menetap > 2 minggu atau disertai gejala sifilis primer/sekunder menandakan kemungkinan infeksi ulang atau gagal terapi.
--	---

	RPR Titer Sifilis Aktif Evaluasi Bulan ke-1, 3, 6, 9, 12, 18 dan 24 Sifilis Laten Evaluasi Setiap 3 bulan sekali pada tahun pertama dan 6 bulan sekali pada tahun kedua Jika terjadi penurunan Titer RPR 4 kali dalam waktu 6 bulan setelah pengobatan, misalnya dari 1:64 menjadi 1:16 atau lebih kecil, maka pengobatan dianggap berhasil. Jika titer tidak turun 4 kali, maka perlu dilakukan evaluasi kemungkinan re-infeksi
	Catatan: *) TP Rapid positif dan belum pernah diterapi maka berikan BP. Jangan sampai pemberian BP terhambat karena tidak tersedianya RPR. Artinya, meski tidak ada RPR maka BP dapat tetap diberikan **) Jika tidak tersedia RPR upayakan rujukan pemeriksaan RPR agar dapat melakukan evaluasi pengobatan. PENCATATAN DAN PELAPORAN SIFILIS A. Verifikasi pasien Petugas (dokter, perawat, petugas data) mengecek NIK pasien sesuai identitas asli (KTP) pada menu kunjungan pasien di SIHA 2.1. B. Jika pasien sudah pernah terdaftar dan melakukan tes : 1. Petugas data menambahkan kunjungan pasien sesuai alasan kunjungan : 2. Mulai perawatan pengobatan : untuk pasien yang memulai pengobatan IMS 3. Tindak lanjut pengobatan : untuk pasien yang sedang dalam pemantauan/monitoring pengobatan. 4. Dokter memberikan resep pengobatan sesuai kebutuhan dan kondisi pasien. 5. Apoteker memberikan obat sesuai resep dokter dan menginputkan resep obat yang diberikan ke pasien di SIHA 2.1 C. Jika pasien belum pernah terdaftar dan belum pernah tes : 1. Petugas data menambahkan data pasien baru dengan menginput NIK dan nama lengkap sesuai KTP pasien pada menu data pasien

	2. Petugas data/perawat menambahkan kunjungan pasien dengan alasan kunjungan : Tes IMS 3. Dokter menginput anamnesa, pemeriksaan fisik, serta permohonan pemeriksaan laboratorium darah sifilis (TP Rapid/ TPHA dan RPR). 4. Petugas laboratorium melakukan pemeriksaan TP rapid/ TPHA dan RPR, kemudian menginput hasil pemeriksaan tersebut ke dalam SIHA 2.1. 5. Setelah hasil keluar, dokter menginput hasil diagnosis berdasarkan hasil anamnesa, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium, serta menginput status IMS dan status pengobatannya. 6. Jika pasien memerlukan terapi sifilis, dokter menginputkan resep pengobatan. 7. Apoteker menginputkan obat yang diresepkan oleh dokter. D. Seluruh data pemeriksaan, hasil tes, dan pengobatan sifilis juga dicatat ke dalam rekam medis elektronik layanan. <i>Note : Jika hasil tes sifilis reaktif, namun dokter menilai pasien masih dalam tahap monitoring atau belum memerlukan pengobatan, maka:</i> • Kolom “Status IMS” pilih “Dalam Pemantauan Pengobatan. • Kolom “Status Pengobatan” pilih “Tidak Diobati”.
Unit Terkait	1. Bagian Administrasi 2. Layanan HIV dan IMS 3. Poli Kulit dan Kelamin 4. Poli Umum 5. Laboratorium 6. Poli KIA

Bagan Alir



LAMPIRAN 1 : KARTU IMS

[illegible]